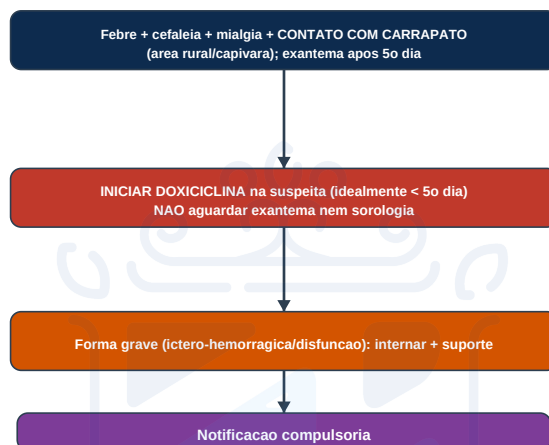


FEBRE MACULOSA — DOXICICLINA NA SUSPEITA

FLUXOGRAMA — TEMPO É VIDA

FEBRE MACULOSA — SUSPEITA -> DOXICICLINA JÁ



DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

O QUE É

- Riquetsiose adquirida pela picada de CARRAPATO infectado; principal agente: *Rickettsia rickettsii* (coccobacilo Gram-negativo intracelular obrigatório)
- Perfis: Sudeste (*R. rickettsii*, carrapato de capivara/áreas rurais; junho-novembro); região metropolitana de SP (cães/gatos na Mata Atlântica); Nordeste (*R. parkeri*, quadro mais leve, escara de inoculação + linfonodomegalia)
- Incubação 2-14 dias
- Doença GRAVE e potencialmente fatal — a suspeição epidemiológica é decisiva
- Notificação compulsória

QUADRO CLÍNICO

EVOLUÇÃO

- Fase inicial (leve): síndrome febril inespecífica ou exantemática — febre, cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, náuseas/vômitos
- Exantema: geralmente APÓS o 5º dia — maculopapular não pruriginoso (1-5 mm), iniciando nas EXTREMIDADES (punhos/tornozelos, PALMAS e PLANTAS)
- Pode evoluir para petéquias, sufusões hemorrágicas e NECROSE de extremidades
- Formas fulminantes (óbito < 6 dias): o exantema pode nem ter tempo de aparecer
- Grave: síndrome febril hemorrágica ou íctero-hemorrágica, disfunção orgânica múltipla, hemorragias, icterícia, choque

EXAMES E DIAGNÓSTICO

NÃO ATRASAR O TRATAMENTO

- Laboratório (apoio): leucopenia ou leucocitose, PLAQUETOPENIA, elevação de CPK, HIPONATREMIA, marcadores de disfunção orgânica
- Diagnóstico definitivo NÃO é ágil — iniciar o tratamento pela CLÍNICA + epidemiologia, sem aguardar confirmação
- Sorologia pareada (IgG fase aguda + nova amostra ≥ 14 dias): aumento de 4x no título = confirmado (IgM tem sensibilidade/especificidade limitadas)
- Na fase aguda: isolamento direto (limitado) ou PCR (boa sensibilidade/especificidade, pouco disponível) em sangue/pele/vísceras
- NÃO se faz profilaxia após picada de carrapato

TRATAMENTO — DOXICICLINA É A CHAVE

Rx PRECOCE SALVA VIDAS

Iniciar diante da SUSPEITA, idealmente ANTES do 5º dia — principal medida para reduzir formas graves (mesmo sem exantema, se houver contato com carrapato)

1ª linha: DOXICICLINA 100 mg EV ou VO 12/12h (adultos e crianças ≥ 45 kg)

Duração: mínimo 5-7 dias OU até pelo menos 3 dias após a resolução da febre/melhora clínica

Via EV preferencial se vômitos, alteração de consciência ou instabilidade; trocar para VO quando estável

Alternativa (só se contraindicação absoluta à doxiciclina): Cloranfenicol 500 mg VO 6/6h (grave: 1 g EV 6/6h) — associado a MAIOR mortalidade; considerar em gestantes/alergia grave; monitorização hematológica

As ÚNICAS drogas eficazes contra *R. rickettsii* são doxiciclina e cloranfenicol

SUORTE E MEDIDAS GERAIS

Rx NO PS / INTERNAÇÃO

Internação hospitalar; dieta VO se tolera (jejum se vômitos/alteração de consciência); SSVV 4/4h; controle de diurese; monitorização se instável

Hidratação: SF 0,9% ajustado ao estado volêmico e à função renal; balanço hídrico rigoroso (risco de edema pulmonar por extravasamento capilar)

Vasopressores se hipotensão refratária; isolamento de contato NÃO é necessário

Sintomáticos: Dipirona 1 g EV 6/6h se febre; Ondansetrona 4-8 mg EV 8/8h se náuseas/vômitos

Exames: hemograma com plaquetas, função renal, eletrólitos (Na), transaminases, sorologia/PCR para rickettsias

REAValiação E INTERNAÇÃO

DECISÃO

- ☐ Espera-se melhora da febre em 24-48h se o tratamento foi iniciado precocemente
- ☐ Sem resposta em 48h: considerar diagnóstico alternativo ou coinfeção (graves podem demorar > 48 h)
- ☐ INTERNAR: disfunção orgânica (renal/hepática/respiratória), trombocitopenia grave, alteração do estado mental, necessidade de suporte (volume/vasopressor/VM), incapacidade de VO, comorbidade/imunossupressão
- ☐ Vigiar complicações: IRA, SARA, alterações neurológicas, choque
- ☐ Notificação compulsória

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; suspeita de febre maculosa; contato com carrapato/área de mata/capivaras nos últimos 15 dias: ____; início dos sintomas ____.
- Clínica: febre/cefaleia/mialgia ____, exantema (palmas/plantas) ____, vômitos ____; sinais de alarme: hipotensão/alteração de consciência/oligúria/fenômenos hemorrágicos ____.
- DOXICICLINA iniciada às ____ (dose ____); hidratação ____; sintomáticos.
- Solicito unidade de referência com suporte/UTI; notificar Vigilância. Iniciar doxiciclina SEMPRE na suspeita, mesmo sem exantema.



FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a principal medida para reduzir o risco de formas graves na febre maculosa?

- A) Aguardar o exantema para iniciar o tratamento
- B) Iniciar doxiciclina precocemente diante da suspeita (idealmente antes do 5º dia), sem aguardar confirmação
- C) Solicitar sorologia pareada antes de tratar
- D) Profilaxia após picada de carrapato
- E) Corticoide em altas doses

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o antibiótico de primeira linha para a febre maculosa brasileira?

- A) Azitromicina
- B) Doxiciclina
- C) Penicilina G
- D) Ceftriaxona
- E) Vancomicina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual característica do exantema é típica da febre maculosa?

- A) Pruriginoso, poupando palmas e plantas
- B) Maculopapular não pruriginoso, iniciando nas extremidades e acometendo palmas e plantas
- C) Vesicular em dermatômo
- D) Apenas no tronco
- E) Em alvo

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quais alterações laboratoriais podem apoiar a suspeita de febre maculosa?

- A) Hipernatremia e leucocitose isolada
- B) Plaquetopenia, elevação de CPK e hiponatremia
- C) Hipoglicemia isolada
- D) Eosinofilia
- E) Anemia macrocítica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o uso de cloranfenicol na febre maculosa, é correto:

- A) É a primeira escolha em todos os casos
- B) Reserva-se a contraindicação absoluta à doxiciclina (ex.: gestante/alergia grave); associa-se a maior mortalidade
- C) É contraindicado em qualquer situação
- D) Não tem ação contra Rickettsia
- E) Substitui a internação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Iniciar doxiciclina precocemente diante da suspeita (idealmente antes do 5º dia), mesmo sem exantema e sem confirmação laboratorial, é a principal medida para reduzir formas graves e a mortalidade.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A doxiciclina é a 1ª linha (superior); o cloranfenicol é alternativa apenas quando há contraindicação absoluta à doxiciclina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O exantema é maculopapular não pruriginoso, surge após ~5º dia, inicia nas extremidades (punhos/tornozelos) e acomete palmas e plantas, podendo evoluir para petéquias.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Plaquetopenia, elevação de CPK e hiponatremia apoiam a suspeita; o diagnóstico definitivo (sorologia pareada/PCR) não deve atrasar o tratamento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O cloranfenicol fica reservado à contraindicação absoluta da doxiciclina (gestante/alergia grave) e associa-se a maior mortalidade, exigindo monitorização hematológica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico